

SEHA

Clinic Operations & RME Platform — “Kembalikan Waktu Dokter untuk Pasien”

Versi: 2.0 Tanggal: 20 Juni 2026 Basis: Solo (Surakarta)

Kerangka: TAM/SAM/SOM · Porter · SWOT · SaaS Unit Economics · DCF

Dokumen perencanaan internal. Angka pasar bersumber data publik (Kemenkes, riset pasar); proyeksi finansial bersifat **asumsi yang dieksplisitkan** dan wajib divalidasi. Bukan nasihat finansial/hukum.

0. Metodologi & Kerangka Analisis

Analisis disusun mengikuti kerangka strategi & valuasi standar konsultan manajemen dan investor:

Area	Kerangka	Output
Ukuran pasar	TAM / SAM / SOM (top-down & bottom-up)	Potensi pasar & target realistis
Struktur industri	Porter's Five Forces	Daya tarik industri
Posisi strategis	SWOT & peta posisi kompetitif (2x2)	Diferensiasi
Ekonomi unit	SaaS metrics: CAC, LTV, LTV:CAC, CAC payback, churn, Rule of 40	Kesehatan model bisnis
Proyeksi	P&L 5 tahun, build-up kohort klinik, break-even	Lintasan finansial
Valuasi/kelayakan	DCF (NPV, IRR, payback), analisis skenario & sensitivitas	Imbal hasil investasi
Risiko	Matriks probabilitas x dampak	Mitigasi terprioritas

1. Ringkasan Eksekutif

SEHA adalah platform operasional klinik & Rekam Medis Elektronik (RME) **sederhana, cepat, low-click** untuk praktik mandiri & klinik kecil. Didorong kewajiban RME (UU Kesehatan 17/2023) dan dorongan SATUSEHAT, pasar primer-care yang belum terdigitalisasi sangat besar. Model bisnis SaaS langganan tahunan (Rp14,4jt/klinik) dengan basis biaya tim di Solo yang efisien.

TAM (ARR potensial) Rp332 M	Break-even ±47 klinik	LTV : CAC ±16 : 1	CAC payback ±6 bulan
NPV @20% (5 thn) +Rp390 jt	IRR (5 thn) ±48%	Kebutuhan modal ±Rp400 jt	Profit mulai Tahun 3

Putusan: LAYAK (GO). Ekonomi unit sangat sehat (LTV:CAC & payback jauh melampaui benchmark); kendala utama adalah **skala & runway** — overhead tetap memerlukan ±47 klinik untuk tertutup. Dengan modal ±Rp400jt dan eksekusi akuisisi disiplin, proyek mencapai break-even di Tahun 2–3 dan IRR ±48% dalam 5 tahun.

2. Analisis & Ukuran Pasar (TAM / SAM / SOM)

2.1 Data dasar (Kemenkes, Profil Kesehatan Indonesia 2024)

Fasilitas	Jumlah
Klinik pratama	14.564
Klinik utama	2.697
Klinik milik swasta (dari total)	15.311
Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD)	8.465
Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (TPMDG)	3.946

2.2 Bottom-up sizing (segmen sasaran SEHA)

Lapisan	Definisi	Unit	ARR potensial @Rp14,4jt
TAM	Klinik pratama + TPMD (primary care kecil) seluruh Indonesia	±23.000	Rp331,6 miliar
SAM	Swasta, terjangkau digital, fokus Jawa (±25% TAM)	±5.750	Rp82,8 miliar
SOM (5 thn)	Target realistis tim ramping (±5% SAM)	±300	Rp4,32 miliar
SOM (3 thn)	Target jangka pendek	±120	Rp1,73 miliar

Cross-check top-down: pasar EMR Asia-Pasifik tumbuh ±6,2% CAGR (2025–2032), didorong mandat digitalisasi & pertumbuhan kelas menengah; segmen klinik-sederhana adalah niche bernilai ratusan miliar di Indonesia. SOM 300 klinik = ±0,1% TAM (sangat konservatif).

3. Struktur Industri — Porter's Five Forces

Gaya	Intensitas	Penjelasan
Persaingan antar pemain	Sedang–Tinggi	Banyak vendor EMR, tetapi sedikit yang fokus ultra-simpel untuk praktik solo
Ancaman pendatang baru	Sedang	Barrier teknologi rendah, tetapi kepercayaan, kepatuhan & integrasi SATUSEHAT menaikkan barrier
Daya tawar pemasok	Rendah–Sedang	Cloud terkomoditas; biaya AI (Claude) tersubstitusi
Daya tawar pembeli	Sedang	Klinik sensitif harga, namun switching cost tinggi setelah data masuk (stickiness)
Ancaman substitusi	Sedang	Kertas/aplikasi generik; namun regulasi mendorong ke RME resmi

Kesimpulan: industri cukup menarik bagi pemain terdiferensiasi pada sumbu *kesederhanaan + kepatuhan + harga*, dengan stickiness yang melindungi basis pelanggan.

4. SWOT & Posisi Kompetitif

Strengths	Weaknesses
Low-click & mudah; fitur KMS pediatri	Gross margin awal rendah (40%)
Harga terjangkau; basis biaya Solo efisien	Ketergantungan engineering tunggal
Kesiapan kepatuhan RME & SATUSEHAT	Keamanan/auth produksi belum siap
Prototype 17 halaman sudah live	Mesin penjualan belum terbukti
Opportunities	Threats
Mandat RME (UU 17/2023) — TAM besar	Kompetitor bermodal besar
Integrasi SATUSEHAT sebagai pembeda	Kewajiban PDP & liabilitas data
Ekspansi regional & multi-vertikal	Adopsi klinik lambat
Add-on Fase 2 (WhatsApp, billing)	Risiko kurs (biaya Claude USD)

Peta posisi (2x2 — Kesederhanaan vs Kelengkapan): EMR rumah sakit berada di kuadran “kompleks & lengkap”; SEHA mengklaim kuadran “**sangat sederhana & cukup lengkap**” yang kurang terlayani untuk praktik solo — strategi blue-ocean pada segmen yang diabaikan pemain besar.

5. Model Bisnis & Ekonomi Unit

5.1 Aliran pendapatan

- Langganan tahunan: **Rp14,4jt/klinik** (all-in).
- Onboarding sekali: Rp3jt (net-neutral terhadap biaya setup; di luar P&L inti).
- Add-on Fase 2: WhatsApp, SATUSEHAT, billing — dikuotasi terpisah.

5.2 Ekonomi unit per klinik & perbandingan benchmark

Metrik	SEHA	Benchmark SaaS 2026	Verdict
ARPU / ARR per klinik	Rp14,4 jt	—	—
Gross margin	40% → 60%	70–85%	Di bawah → naik
CAC per klinik	±Rp3 jt	—	—
Kontribusi / klinik / tahun	Rp5,8 jt	—	—
CAC payback	±6 bln	SMB <12 bln	Sangat baik
Churn tahunan (asumsi)	12%	SMB bln <2–3%	Wajar
LTV (konservatif)	±Rp48 jt	—	—
LTV : CAC	±16 : 1	3–5 : 1	Sangat baik*

*LTV:CAC tinggi karena CAC rendah (penjualan founder/BD basis Solo). Bahkan pada churn 20%, LTV ±Rp29jt → LTV:CAC ±10:1 (tetap di atas benchmark). Gross margin di bawah benchmark adalah area perbaikan utama — membaik seiring skala (infra & support ter-amortisasi).

Rumus: CAC payback = CAC ÷ (kontribusi bulanan) = 3 ÷ (5,8/12) ≈ 6,2 bln · LTV = ARPU × GM ÷ churn · LTV:CAC = LTV ÷ CAC.

6. Struktur Biaya

Overhead General (perusahaan) — basis Solo

Komponen	/tahun
Langganan Claude (Team) — US\$200 @ Rp16.500	Rp39,6 jt
Gaji CEO (Solo)	Rp144 jt
Gaji BD & Product Strategy (Solo)	Rp84 jt
Total (Tahun 1)	Rp267,6 jt

COGS langsung per klinik

Komponen	/tahun
Domain	Rp0,2 jt
Cloud hosting	Rp2,4 jt
Database & storage	Rp1,8 jt
Backup & monitoring	Rp0,6 jt
Pemeliharaan & dukungan	Rp3,6 jt
Total COGS / klinik	Rp8,6 jt

CapEx (one-time): pengembangan produk **Rp108jt** — diperlakukan investasi, bukan dibebankan ke satu klinik.

7. Proyeksi Keuangan 5 Tahun (Skenario Dasar)

Asumsi: akuisisi naik bertahap; churn 12%/thn; gross margin membaik 40%→60% seiring skala; harga Rp14,4jt; OpEx tumbuh moderat.

7.1 Build-up klinik (kohort)

Tahun	Awal	Akuisisi	Churn (12%)	Akhir	Rata-rata aktif
1	0	24	0	24	12
2	24	39	3	60	42
3	60	67	7	120	90
4	120	94	14	200	160
5	200	124	24	300	250

7.2 Laporan Laba Rugi (Rp juta)

Akun	Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5
Pendapatan langganan	172,8	604,8	1.296,0	2.304,0	3.600,0
COGS langsung	(103,2)	(336,0)	(648,0)	(1.040,0)	(1.450,0)
Laba Kotor	69,6	268,8	648,0	1.264,0	2.150,0
Gross margin	40%	44%	50%	55%	60%
OpEx (S&M, R&D, G&A)	(267,6)	(360,0)	(540,0)	(780,0)	(1.080,0)
EBITDA	(198,0)	(91,2)	108,0	484,0	1.070,0
EBITDA margin	-115%	-15%	8%	21%	30%
Rule of 40 (growth% + margin%)	—	235	122	99	86

Rule of 40 di atas 40 di seluruh tahun (Thn 2 terinflasi basis kecil). Benchmark elite >60 — terlampaui pada Thn 3–5.

8. Analisis Titik Impas (Break-even)

Pendekatan	Perhitungan	Hasil
Break-even jumlah klinik (Thn 1)	Overhead Rp267,6jt ÷ kontribusi Rp5,8jt	±47 klinik
Break-even waktu (operasional)	Tercapai saat klinik aktif ≥ ±47	Pertengahan Thn 2
EBITDA positif (tahunan)	Saat laba kotor > OpEx	Tahun 3
Cumulative cash break-even	Akumulasi arus kas ≥ 0	Tahun 4

9. Arus Kas Kumulatif & Kebutuhan Modal

Periode	Arus kas tahun	Kumulatif
Thn 0 — CapEx build	(108,0)	(108,0)
Tahun 1	(198,0)	(306,0)
Tahun 2 — titik terendah	(91,2)	(397,2)
Tahun 3	108,0	(289,2)
Tahun 4 — modal kembali	484,0	194,8
Tahun 5	1.070,0	1.264,8

Kebutuhan modal (runway) ≈ Rp400 juta (CapEx Rp108jt + akumulasi rugi T1–T2). **Penggunaan dana:** ±27% pengembangan produk, ±60% gaji tim & operasional s/d break-even, ±13% pemasaran & cadangan.

10. Imbal Hasil Investasi (DCF)

Tahun	Arus kas bebas (Rp jt)	Faktor diskonto @20%	PV (Rp jt)
0	(108,0)	1,000	(108,0)
1	(198,0)	0,833	(165,0)
2	(91,2)	0,694	(63,3)
3	108,0	0,579	62,5
4	484,0	0,482	233,4
5	1.070,0	0,402	430,0
NPV @20%			+389,6

NPV @20%
+Rp390 jt

IRR (5 thn)
±48%

Payback kumulatif
Tahun 4

Diskonto (asumsi)
20%

Diskonto 20% mencerminkan risiko startup tahap awal Indonesia. IRR ±48% jauh di atas biaya modal → proyek menciptakan nilai. Belum termasuk nilai terminal/akuisisi (upside tambahan).

11. Analisis Skenario

Parameter	Bear	Base	Bull
Akuisisi (vs base)	0,5x	1,0x	1,5x
Churn tahunan	20%	12%	8%
Klinik akhir Thn 5	±150	300	±480
Break-even	Thn 4	Thn 2–3	Thn 2
Puncak kebutuhan modal	±Rp650 jt	±Rp400 jt	±Rp300 jt
EBITDA Thn 5	±Rp350 jt	Rp1.070 jt	±Rp1.900 jt

Bahkan pada skenario bear, proyek tetap mencapai profitabilitas (Thn 4) — risiko utama adalah ukuran runway, bukan kelangsungan model.

12. Analisis Sensitivitas (Break-even Klinik)

Break-even klinik = Overhead ÷ kontribusi per klinik. Sensitif terutama terhadap harga & COGS.

Perubahan	Kontribusi/klinik	Break-even klinik	Δ vs base
Harga +20% (Rp17,28jt)	Rp8,68 jt	31	-16
Base (harga Rp14,4jt)	Rp5,80 jt	47	—
Harga -20% (Rp11,52jt)	Rp2,92 jt	92	+45
COGS -20% (Rp6,88jt)	Rp7,52 jt	36	-11
Overhead +20% (Rp321jt)	Rp5,80 jt	55	+8

Implikasi: harga adalah tuas paling kuat. Sedikit kenaikan harga (atau penurunan COGS via efisiensi) menurunkan break-even secara signifikan — sebaliknya perang harga sangat merusak.

13. Penilaian Kelayakan

Dimensi	Putusan	Catatan
Teknis	Sangat Layak	Next.js + cloud; prototype live
Operasional	Layak	Low-click; onboarding ringan
Pasar	Layak	TAM Rp332M; mandat RME
Finansial	Layak	NPV+, IRR ±48%, unit economics kuat
Hukum	Bersyarat	Hardening PDP/RME sebelum data nyata
Risiko	Terkelola	Mitigasi tersedia (lihat §14)

14. Matriks Risiko (Probabilitas × Dampak)

Risiko	Prob.	Dampak	Skor	Mitigasi
Akuisisi lebih lambat	Sedang	Tinggi	Tinggi	Pilot kuat, referral, fokus regional, harga kompetitif
Runway kurang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Overhead Solo rendah, milestone funding, pendapatan onboarding
Kepatuhan PDP/RME	Sedang	Tinggi	Tinggi	Hardening keamanan, audit, kemitraan kepatuhan
Gross margin rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	Otomasi support, efisiensi infra, naikan harga/ARPU
Kompetitor besar	Sedang	Sedang	Sedang	Diferensiasi simpel + pediatri + harga
Ketergantungan engineering	Sedang	Sedang	Sedang	Dokumentasi, kode terstruktur, rekrut bertahap
Risiko kurs (Claude USD)	Tinggi	Rendah	Rendah	Porsi kecil dari biaya; dapat disubstitusi

15. Roadmap

Fase	Fokus
Fase 1 — MVP (selesai)	Operasional inti + RME + KMS + kasir + dashboard + website publik
Fase 1.5 — Hardening	Autentikasi, database, enkripsi, audit log, kepatuhan PDP/RME
Fase 2 — Automasi	WhatsApp, SATUSEHAT dua arah, billing/asuransi, analitik
Fase 3 — Skala	Self-service onboarding, multi-cabang, ekspansi nasional

16. Asumsi Kunci

- Harga langganan Rp14,4jt; CAC Rp3jt; churn 12%/thn; gross margin 40%→60%.
- Akuisisi: 24 / 39 / 67 / 94 / 124 klinik (gross) pada Thn 1–5.
- OpEx Thn 1 = tiga komponen yang ditetapkan (CEO, BD, Claude) = Rp267,6jt; tumbuh seiring penambahan tim/pemasaran.
- Diskonto DCF 20%; kurs USD/IDR Rp16.500.
- CapEx build Rp108jt; onboarding dianggap net-neutral.

17. Kesimpulan & Rekomendasi

GO. SEHA memiliki ekonomi unit yang sangat sehat (LTV:CAC ±16:1, payback ±6 bulan), pasar besar dengan tailwind regulasi, dan lintasan finansial menarik (NPV +Rp390jt, IRR ±48%). Tantangan utama bukan model, melainkan **eksekusi akuisisi** dan **pendanaan runway ±Rp400jt** hingga break-even (±47 klinik, Tahun 2–3).

Rekomendasi prioritas: (1) galang modal ±Rp400–500jt; (2) menangkan pilot dr. Aisyah sebagai bukti nilai; (3) naikan gross margin via efisiensi support/infra; (4) jaga overhead Solo tetap ramping; (5) selesaikan hardening kepatuhan sebelum skala.

18. Sumber & Referensi

1. Kementerian Kesehatan RI — Profil Kesehatan Indonesia 2024 (jumlah klinik & TPMD).
2. UU No. 17/2023 tentang Kesehatan & Permenkes No. 24/2022 — kewajiban Rekam Medis Elektronik; UU No. 27/2022 (PDP).
3. Riset pasar EMR Asia-Pasifik (CAGR ±6,2%, 2025–2032) — Data Bridge / Mordor Intelligence.
4. Benchmark SaaS 2026 (LTV:CAC, CAC payback, gross margin, Rule of 40) — Phoenix Strategy Group; Beancount.io; Eagle Rock CFO.
5. Kerangka analisis: Porter's Five Forces; SWOT; TAM/SAM/SOM; DCF (NPV/IRR).

Edisi komprehensif. Angka proyeksi adalah asumsi yang dieksplisitkan untuk perencanaan & penggalangan modal — bukan jaminan kinerja, bukan nasihat finansial/hukum. Prototype: seha-clinic.vercel.app